



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : منال محروس محمد حسن
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : الوراق
العنوان : =
رقم البطاقة : 27205102401941 رقم التليفون : 01064083527
العمر (تاريخ الميلاد) : 10-05-1972 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 06-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.
تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: منال محروس محمد حسن National ID: 27205102401941	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

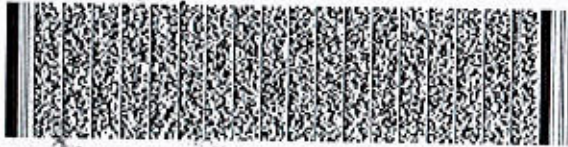
تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الى Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

٢٠٢٣/٠٣/٢٧ (٢٧٢٥٥) ٠٢٤٠١٩٤١
 ربة منزل
 أنثى
 مسلمة
 متزوجة
 الحسيني احمد علي
 البطاقة سارية حتى ٢٠٢٠/٠٣/٢٧ ١



جمهورية مصر العربية
 بطاقة تحقيق الشخصية
 منال
 محروس محمد حسن
 ٦٢ من الراشدي
 الوراق - الجيزة
 ٢٧٢٠٥١٠٢٤٠١٩٤١
 JW4226384





Report Number: m4612

ImmunohistoChemistry report

Female

النوع

القاهرة

العنوان

31/08/2020 11:19

تاريخ استلام العينة

03/09/2020 10:10

تاريخ التقرير

ممثل مخبري من محمد

47 Y

مركز جراحة المرأة

مركز جراحة المرأة

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

ER & PR & HER2 neu & Ki67 (ER&PR: Harvey scoring system -Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample recieved was treated by: - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody - CONFIRM anti-progesterone receptor (PR) (IE2) Rabbit monoclonal primary antibody.
Sample recieved was treated by: - VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX.
Sample recieved was treated by: - CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbit monoclonal primary antibody.

Result :

ER: strong nuclear staining of > 60 % of tumour cells (core biopsy)
PR: moderate nuclear staining of > 60 % of tumour cells (core biopsy)
HER2/neu protein over expression: moderate continuous membrane staining of > 10 % of tumor cells (core biopsy)
Ki67: positive nuclear staining of about 5 % of tumour cells (core biopsy)

Referral Lab :

Comment :

Conclusion :

ER: POSITIVE (SCORE 8 / 8)
PR: POSITIVE (SCORE 7 / 8)
HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION: EQUIVOCAL (SCORE 2+)
Ki67: THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS ABOUT 5 %.

Pathologist

د/نور امان

Lab Director

د/نور امان

Name: MR. :	منال محروس محمد حسن 2418	
Detailed Medical Report		
		السيد
تحية طيبة وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	
إيماء للطلب المقدم من		بقسم:
	رقم طبي:	
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه Premature radiotherapy for breast cancer, right breast conservative surgery on 13/10/2020, T1 N1 2/24, ER 8/8, PR 7/8, HER2 negative, recurrence 4 TC port st. Tamoxifen started in February 2021 for 5 years or shift to AI according to menopausal status. Report of serum markers for tamoxifen requested. BSM performed in October 2025: left indeterminate axillary lymph node for close follow-up. New BSM and targeted ultrasound on left axilla if needed. Otherwise the patient completed 5 years of tamoxifen. E2 and FSH requested to decide further step after E2 and new BSM. FSH 48, E2 15; the patient is still on tamoxifen (5th year finished). BSM will be done; consider stopping endocrine therapy if free. FSH 15, E2 48; the patient is still on tamoxifen (5th year finished). BSM will be done; consider stopping endocrine therapy if free.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	التاريخ : 20-09-2026
ندى حسن صلاح كامل		الطبيب المعالج :
يعتمد ,		



Report Number: m.4612

ImmunohistoChemistry report

Female

القاهرة

03/09/2020 13:54

09/09/2020 14:10

النوع

العلوان

تاريخ استلام العينة

تاريخ التقرير

مركز مجروح محمد

47 Y

مركز صحة المرأة

مركز صحة المرأة

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

HER2 by SISH

Comment :

Technique :

sample received was stained for HER2 gene and chromosome 17 using INFORM HER2 Dual Probe Cocktail technique benchmark GX (VENTANA).

Result :

the ratio of HER2 signal to chromosome 17 in the nuclei of tumor cells is 1.8 (less than 2) indicating no amplification of HER2 gene

Referral lab :

Comment :

Conclusion :

#referred block : HER2 GENE NOT AMPLIFIED. RATIO 1.8 (LESS THAN 2) (CORE BIOPSY)

Pathologist:

د/تريزا ماهر

Lab Director: د/تريزا ماهر

I) POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST REVEALED:

- Bilateral posterior subpleural thin sheets of fibrotic bands ?? sequel of healed COVID 19 pneumonitis for clinical and laboratory correlation..
- No signs of pulmonary nodules, consolidation or cavitation detected.
- No hilar or mediastinal masses or lymphadenopathy detected.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.
- No pleural or pericardial sac collection.
- Few sections taken at the upper abdomen showed fatty hepatomegaly

II) POST CONTRAST CT EXAMINATION OF THE ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

- Mild hepatomegaly showing homogenous low attenuation parenchymal texture . No parenchymal focal lesions or intra-hepatic biliary radicles dilatation seen.
- Patent, homogeneously enhancing portal vein and its main branches.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, kidneys, aorta, IVC and pelvic organs.
- No CT evidence of enlarged abdominal or pelvic lymph nodes.
- No ascites or pelvic collection.
- An IUCD seen in place
- Clear scanned lung bases.

OPINION:-

Mild fatty hepatomegaly, otherwise Normal CT study of the abdomen and pelvis.

Prof. Mohamed Abdelfattah
Dr. Rania Mohamed MSc



Report Number: 435

Histopathology report

Female : النوع
القاهرة : العنوان
25/08/2020 11:18 : تاريخ استلام العينة
01/09/2020 12:10 : تاريخ التقرير

عقل محروس محمد
48 Y

مركز صحة المرأة
مركز صحة المرأة

Primary sample :

right breast core biopsy
comment :

Gross examination :

one core and fragments of greyish white tissue (T.I)

Microscopic examination :

core of fibrofatty tissue involved by invasive tumor tissue arranged in clusters and cords of malignant ductal cells, showing moderate cell anaplasia

Referral Lab :

Comment :

Diagnosis :

RIGHT BREAST CORE BIOPSY: INVASIVE DUCT CARCINOMA, GRADE II

Pathologist:

د. أيمن رمزي

Lab Director. د. نزيها ماهر

Women's Health Outreach Program
ahrous Mohamed

Name: Manal Mahrous Mohamed
Date: Wednesday, 6/11/2024

Date: Wednesday, September 30, 2020

Bilateral Full Field digital mammography with contrast presentation:

Clinical Presentation:

- RT pathology proved breast cancer for pre operative assessment
- Ultrasound Findings:**
- Dense B

Ultrasound Findings:

- Dense fibroglandular pattern (ACR C).
- A RT central asymmetry is seen. No LT spiculations or mass lesions seen.
- After contrast administration there were three heterogenous enhancing masses at 6:00 measuring 1.7cm, 1cm and 6mm in diameter. They start 6cm from the nipple.
- No pathological uptake on the LT side.
- Normal skin/nipple/ areolar complex.
- US demonstrated a RT axillary LN measuring 2.7cm in diameter with cortical thickness 5mm is noted, along with a 1.2cm LN with indistinct hilum.
- LT non specific axillary lymph nodes are seen.

Conclusion:

- RT breast Multifocal malignant masses (BIRADS 6)
- Normal LT breast (BIRADS 1)

Best regards,

Dr. Norran Hussein, MD FRCR

١٠٥٢ من كورنيش النيل - دمياط
٠٢٢٦٤٥٨١٢ هاتف

بريد الإلكتروني: info@whop.gov.eg
الموقع الإلكتروني: www.whop.gov.eg

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department



وزارة الصحة والسكان
مركز التخصص في أمراض السرطان
دار السلام
قسم الأشعة

Patient Name: Manal Mahrous Mohamed Hassan	
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Medical ID: 4255/2020
Age : 50 Year(s)	Pal. ID: 18795
Date : 11/09/2022	

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

patient had right CBS

Report:

- The breasts are almost entirely fatty (ACR A)
 - No right breast suspicious mass lesions, micro calcifications or architectural distortion detected.
 - Right breast UOQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
 - Complementary ultrasound showed right breast UOQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with clear operative bed with no evidence of recurrent mass lesions. Small operative bed seroma measures 1.5 x 2.5 cm
 - No left breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
 - Nonspecific left axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
 - Free right infra and supra clavicular regions.
- Opinion:**
- Right breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
 - Normal study of the left breast (BIRADS 1)

Yours truly

Signature Dr. Aya Deabes

11/09/2022 2:05 PM